

来诊断骨质疏松和骨质减少,遗憾的是,在这些标准中没有考虑男性。

治疗 尽管众所周知骨质疏松症患者人数在逐年增加,但到目前为止尚未有治疗药物被 FDA 批准用来预防和治疗男性骨质疏松。治疗的第一步,是帮助他们改掉不利健康的坏习惯。吸烟、酗酒、过量饮用咖啡以及长期坐着不动都会破坏骨质结构。了解机体每天需要多少钙是必要的。男性直到 50 岁时,每天需要 1 000 mg 钙;超过 50 岁时每天需 1 200 mg;从紫外线、饮食中补充维生素 D (400~800 U/d),并且确保食物钙的吸收。应该鼓励中老年男性进行负重锻炼和耐力训练,以帮助他们增加和保持骨骼及肌肉量。通过减少危险因素和增加药物治疗来预防骨质疏松的发生。Fosomax (alendronate)、Actonel (risedronate)、Miacalcin (calcitonin) 和 Evista (raloxifene) 都已经用来预防和治疗女性患者的骨质疏松。虽然这些药物可能在男性患者中确实有效和耐受性好,但尚未有大量临床试验数据。

(周玉虹 刘志英摘 王海燕校)

172 **精神病病人的思维及其护理** [英] / Chadwick P // Nursing Times. - 2000, 96 (44). - 42

面对一个新入院的精神病病人,护士可能心存疑虑,病人是如何思考的? 该怎样护理病人呢? 无疑,掌握了精神病病人的心理特点才能更易于接近他们。

确诊为精神病的病人控制自己的思维有困难,他们很难区分现实与幻想。首先需要知道的是,精神病病人都试图对其周围的事物赋予某种特定的意义,特别是处于急性期的病人。这些赋予的意义都与其幻想有关,正因如此,护士在与病人接触中要尽量避免使用会产生歧义的语言,因为精神病病人对外界保持高度的敏感,护士模棱两可的语言会引起病人的误解,对病人不利;护士明确、肯定的语言更能获得病人的信任。精神病病人

的另一偏执是对某一事物过度地、超乎常理地分析、解释,如把病房的医务工作者视为秘密侦探等。我们需要做的是鼓励他们按常人的眼光看待事物。另外,精神病病人往往在证据不充分时盲目下结论,而当受到质问时又以相矛盾的证据改变原来的结论。一个精神病病人的妄想会影响他对外界事物的反应,而这使得病人与正常人对同一外界事物的反应是不一样的,这一妄想并不随病人入院而结束。我们应该认识到这种妄想或者说偏执在许多有强烈信念的正常人中也有。它本身并非异常,只是在精神病病人中这种妄想达到失控的程度,他们将自己的信念错误地理解成现实。如果病人明白这一点,将信念理解为有事实依据的假说(象科学研究中一样)时,病人就有救了。而现实中很难做到这一点。我们应多与病人沟通,不能任其胡思乱想。但是,直接接触及病人症结的谈话也不可行。与病人泛泛地聊些生活琐事,使病人感受到友情,反而对病人病情恢复有利。

最后值的一提的是,精神病病人的思维方式与正常人并无本质上的区别。盲目下结论、自以为是、偏执,以及在某种程度上的事实与幻想的辨别能力失常在正常人也时有发生。精神病病人并不是心理怪物,他们只是过于神入、敏感。精神病病人的思维方式填补了我们生活中的原来以为毫无价值的空缺,其实它也有其精神上 and 存在上的价值。如果把妄想乃至精神病病人思维方式比作一种危险、恐怖的旅行,恰当的治疗则能使其变得安全而易于控制。从这点上说,所有医生、护士、临床精神分析专家都有义务参与治疗。

(李琳摘 程显山校)

173 **精神病病人所用药物相互作用的危险** [英] / Hamilton I ... // Nursing Times. - 2000, 96 (46). - 41

据估计英国 1% 的人口 (大约 60 万人) 被认为患有精神分裂症。将近 50% 的精神病

病人使用违禁药物。因此，药物相互作用则是成千上万名病人的潜在危险。研究表明，这些违禁药物能够减轻精神病病人的症状，另外，违禁药物亦可能被试图用于控制副作用。

“英国国家处方”中的黄色卡片，是用来报告药物相互作用的。作者认为需要进一步宣传黄色卡片的作用，卫生部门应当鼓励医生信任药物报告政策并对医生进行相关内容的培训。研制一种药物相互作用的评估工具也是必不可少的。得出违禁药物使用的类型、结果和数量，并将其与处方类药物进行比较，将帮助医生决定药物相互发生作用的可能性。这些信息将对病人群体有利。某些精神健康医生可能担心这样做会导致病人拒绝他们的处方药物。这也有可能，但并非决定性因素。病人有权了解所用药物的作用及副作用。从专家到低年资的精神病科医生对处方负有责任。而护士则有更多的机会去评估药物相互作用的影响，宣传处方药物的功效。因为他们同病人面对面的接触机会较多。

一旦药物相互作用的可能性被认定，应采取以下步骤：（1）研究选择替换药物；（2）列出药物在每一阶段对病人有利或不利的方面。（3）讨论可选择的方案，诸如停药或减少用量。当然，如果病人选择继续使用这些药物，那么这样做是困难的，然而，对病人用药间隔时间进行重新选择同样是值得的。

结论 对精神病病人滥用药物和同时服用毒麻药的危险性不能低估。因为这样除了有药物相互作用的可能性之外，尚有引起病人自杀的危险。精神健康工作者必须对这些问题给予有效的关注。将这些知识传授给病人，可以使他们减少自杀的风险。

（荆素卿摘 程显山校）

174 护士对急症精神病病人请假外出的对策[英]/Renine P//Nursing Times. - 2000, 96 (34). - 46
中国知网 <https://www.cnki.net>
有些不受心理卫生法（MHA，1983）约

束的急症精神病病人在住院期间经常提出短时外出的要求，如去商店购物等，这常常使护士难以决定是否允许他们外出，因为需要考虑病人的安全和人身自由两方面的因素。作者研究探讨了如何批准或否决病人的请假要求，从而为急症精神病房的护士提供帮助。

方法 通过对 4 种人员集中访谈的方式收集资料。这 4 种人员分别是高级护士、初级护士、曾住院病人和护理员，每次访谈均要录音，然后进行定性分析，以确定如何使用这些调查资料来指导临床实践。

根据访谈资料，作者归纳、制定了供护士决定时参考的树状结构内容（见表 1），可据此作出准假决定。

表 1 批准精神病病人短假考虑要点及解释

要点	详细解释
病人表现	第一印象：他们穿着如何？携带什么东西？这些东西是否都是他们自己的？他们是否紧张？
病人的要求是什么	是为自己还是为他人要求？要求合理吗？他们有钱吗？
病人怎样问的	语调、语气，是口头的还是书面的？是含糊的还是神秘的？是在您忙时或你忙前故意问的吗？
护士内心感受	默认、直感、直觉、预感。
病人病史	缺少这方面的资料使评估非常困难，病史的性质是什么？住院多长时间？
危险因素	是否确认有自杀、自伤、危害他人、酗酒、吸毒的危险？信息是否从非正式渠道得来的？不能对危险因素做出评估则难以做出准假的决定。
小组的影响	其他人有什么想法？要考虑护理计划、治疗计划、多学科小组查房意见及某些案例的政治影响。
病人对自己被检查的反应如何	病人是否因为检查程序或因未报告自己有酗酒、吸毒或伤害他人或自己的潜在意向而感到焦虑不安？是否认为请假是无可非议的紧急之事？排除医院的激怒因素，考虑其同医院配合的可能性。
病人最近的情况怎样	是否有已知的刺激因素？
熟悉病人情况	如护士不熟悉病人，则难判定是否准假

结果 此“树状结构”为护士能否批准病人请假提供了参考，护士可以拿着预先印